

Утверждаю _____

Ректор ТашГосМИИ _____

проф. Даминов Т. А.

«15» июня 1998



АКТ №

от «15» июня 1998 г.

о результатах клинического применения инфракрасного
облучения, излучателем ГЛ-05, при лечении больных с
хирургической патологией

Узбекистан НПЦ «InfraR»

Испытания (апробация метода) проводились на кафедре
хирургических болезней ТашГосМИИ - 1

Целью испытания является изучение бактерицидного воздействия
инфракрасного излучателя ГЛ-05, основанного на противовоспалительном
и антибактериальном действии.

Для проведения испытания были предъявлен ИК излучатель ГЛ-05
общего и локального воздействия. Представлены методические
рекомендации на применение данного излучателя.

Лечение проводилось больным с хирургической патологией
различной локализации.

Клинические исследования

Всего под наблюдением находилось 32 больных (11 женщин и 21 мужчина). При полном комплексном клиническом обследовании выявлено:

острый аппендицит - 8 больных

язвенная болезнь 12-перстной кишки - 8 больных

рубцовое сужение пищевода после химического ожога - у 3-х больных

кардиоспазм 4-й степени - 1 больной

сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа - 1 больной

рецидивирующий эхинококк печени - 1 больной

колото-резаная рана - 3 больных

постинъекционный абсцесс ягодицы - 2 больных

лигатурный свищ после операции по средней линии живота. Инфильтрат брюшной полости - 1 больной

лимфаденит - 1 больной

пневмоторакс, экссудативный плеврит - 1 больной

состояние после резекции 2/3 желудка, пептическая язва анастомоза - 1 больной

укушенные раны - 1 больной

22 больным, была проведено оперативное вмешательство, после чего проводилось облучение инфракрасным излучателем серии ГЛ-05, с целью снятия воспаления послеоперационной раны. Характерно, что у тех больных, которые получали облучение инфракрасным излучателем серии ГЛ-05, не отмечалось осложнение в виде нагноения раны. У всех больных отмечалось заживление послеоперационного рубца первичным натяжением. Сроки заживления раны, а также выписка больных ускорились в 2 раза.

Следующая группа больных с гнойными процессами в брюшной полости. В послеоперационном периоде у тех больных, которые получали

облучение инфракрасным излучателем серии ГЛ-05, гнойное отделяемое из дренажной трубки прекратилось на 2 -3 день, рассасывание инфильтрата на 3 - 4 день. В результате чего дренажная трубка была удалена на 3 4 дня раньше обычных сроков. Температура этих больных нормализовалась на 2 - 3 день и больные получали антибиотики 2 - 3 дня. У группы больных лечившихся без ИК излучателя антибиотикотерапия длилась 6-7 дней, выздоровление наступало на 10-12 день.

Следующая группа это те больные которые благодаря предоперационной обработке ИК излучателем ГЛ-05 избежали полостной операции: острый аппендицит - 1 больной; пептическая язва анастомоза - 1 больной; постожоговое сужение пищевода - 1 больной.

У группы больных подготавливающихся к большой полостной операции в результате обработки ИК излучателем ГЛ-05, в предоперационный период, объем операции был значительно уменьшен, за счет отсутствия перифокального воспаления. Технически операция стала менее сложной, чем предполагалось. Течение послеоперационного периода стало более легким (отсутствие температуры у некоторых больных, нормализация на 2-й день, общее состояние больных сохранялось удовлетворительным).

Больным с колото-резанными ранами, в результате лечения ИК излучателем ГЛ-05, проводилось только первичная хирургическая обработка ран, заживление раны наступало первичным натяжением, без назначения антибиотиков. Выздоровление наступало на 3 - 5 - 7 дней раньше, чем у других больных, не получавших лечение ИК излучателем

У группы больных получавших лечение ИК излучателем ГЛ-05 в послеоперационном периоде на 2 день, после начала лечения отмечалась нормализация температуры и общего состояния. У контрольной группы не ранее, чем на 5-й день.

Больные с постинъекционными абсцессами были выписаны с выздоровлением при полном рассасывании инфильтрата на 5 -й день после начала лечения, при это назначенные антибиотики были отменены на 2-й день, после начала терапии (при обычной терапии антибиотики назначаются не менее 6-7 дней, больные выписываются с сохранением инфильтратов в основании очага).

У больной поступившей с укусами собаки, после терапии ИК излучателем ГЛ-05, заживление раны наступило на 2-й день.

Больной готовившейся к операции по поводу «prurigo ani» (страдает 15 лет) в результате однократной обработки ИК излучателем ГЛ-0,5, был выписан, т. к. зуд прекратился.

Методика ИК облучения

Использовался ИК излучатель ГЛ-05 общего и локального воздействия. Время экспозиции излучателя устанавливалось индивидуально и составляло в среднем от 10 до 30 минут. Больной находился в положении лежа на спине или как больному удобно, на ровной кушетке, в хорошо вентилируемом помещении. Расстояние от лампы до больного 80 см. Общее воздействие проводилось для снятия воспалительного процесса во всём организме и восстановления нормальных функций организма.

После проведения общей процедуры, проводилось локальное облучение в проекции расположения послеоперационных ран. Локальное воздействие проводилось в нескольких проекциях (от 3 до 5). Время облучения - от 10 до 15 мин. 2-3 раза в день.

Результаты проведённого лечения оценивались по рекомендации ВОЗ, как полное выздоровление, частичное выздоровление, то есть улучшение общего состояния, отсутствие эффекта от лечения ИК излучателя.

В результате терапии ИК излучателем ГЛ-05 у всех больных отмечалось значительное уменьшение болевого синдрома, улучшение аппетита, повышение общей активности, нормализация температуры тела, нормализация сна. Ни у одного из больных, находящихся на лечении ИК излучателем ГЛ-05, не отмечалось ухудшение общего состояния и прогрессирование воспалительного процесса, в частности в послеоперационных ранах.

У 72% больных отмечалось быстрое заживление ран первичным натяжением и выздоровлением, а у 38% на фоне улучшения общего состояния отмечалась ремиссия заболевания.

Учитывая все эти данные, что метод ИК излучения излучателем серии ГЛ-05, может быть рекомендован в качестве компонента комплексного лечения хирургических болезней, как предоперационная подготовка больных, так же как и послеоперационное лечение их.

« ____ » _____ 1998 г.

Руководитель испытания

зав. каф. ТашГосМИ 1

д.м.н. проф. _____ Янгиев А.Х.

В результате терапии ИК излучателем ГЛ-05 у всех больных отмечалось значительное уменьшение болевого синдрома, улучшение аппетита, повышение общей активности, нормализация температуры тела, нормализация сна. Ни у одного из больных, находящихся на лечении ИК излучателем ГЛ-05, не отмечалось ухудшение общего состояния и прогрессирование воспалительного процесса, в частности в послеоперационных ранах.

У 72% больных отмечалось быстрое заживление ран первичным натяжением и выздоровлением, а у 38% на фоне улучшения общего состояния отмечалась ремиссия заболевания.

Учитывая все эти данные, что метод ИК излучения излучателем серии ГЛ-05, может быть рекомендован в качестве компонента комплексного лечения хирургических болезней, как предоперационная подготовка больных, так же как и послеоперационное лечение их.